

TCE · Glasgow, TC e hipertensão intracraniana

No TCE, evite hipóxia e hipotensão — são os maiores determinantes de lesão secundária. Classifique por Glasgow, obtenha TC e trate HIC/herniação sem demora.

Indicações de IOT

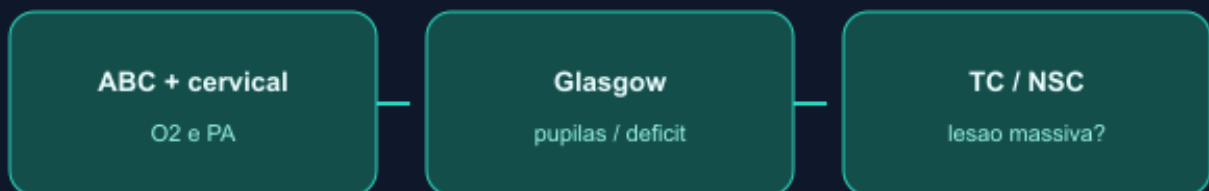
Lembre - Indicações de IOT

ECG "d8, queda progressiva, agitação incompatível com proteção de via, hipoxemia/hipoventilação ou necessidade de hiperventilação temporária na herniação.

Fluxo ATLS: via aérea com proteção cervical, oxigenação, PA e avaliação neurológica seriada.

TCE na porta

ABC -> ECG -> TC / neurocirurgia



Manejo da HIC / herniação

- Cabeceira 30°, colo neutro, sedação adequada, normocapnia
- Manitol ou SF hipertônico na herniação iminente
- Hiperventilação breve só como ponte para cirurgia
- Hematoma epidural/subdural com efeito de massa !' neurocirurgia

Lesões clássicas

Lesão | Pista

Epidural | Intervalo lúcido; lente biconvexa

Subdural | Idoso/álcool; crescente

Difusa axonal | Coma, TC pode ser pobre

Base de crânio | Battles, raccoon, otorraquia

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não faça sonda nasogástrica se houver suspeita de fratura de base de crânio — use via oral. Evite hipotensão com cristaloides/sangue; PAM baixa piora isquemia cerebral.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1